



**MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES**

*Oriente
Agilité
Projet*

**PERMETTRE AUX MÉDECINS DE MIEUX
REPÉRER LES FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES**

L'APPORT DES SCIENCES COMPORTEMENTALES

**Novembre
2022**

**Direction interministérielle de
la transformation publique**



PRÉSENTATION DE LA DITP

La direction interministérielle de la transformation publique (DITP) est placée sous l'autorité du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Elle regroupe plus de 80 experts, chercheurs et consultants internes chargés de coordonner et d'animer le programme de transformation publique.

Ses équipes interviennent dans quatre grands domaines : suivi des réformes prioritaires de l'État, accompagnement des acteurs publics dans la concrétisation de leurs projets de transformation, diffusion de l'innovation publique et amélioration de l'expérience usagers, notamment au travers du programme Services Publics +. L'objectif : une action publique toujours plus proche, plus simple et plus efficace.

En savoir plus :

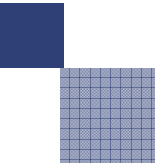
<https://www.modernisation.gouv.fr/>

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
→ Résumé	5
→ Contexte de l'étude	7
DIAGNOSTIC COMPORTEMENTAL	11
SOLUTIONS DÉVELOPPÉES	15
→ La recommandation simplifiée	17
→ Le questionnaire de prévention	22
CONCEPTION DE L'ÉVALUATION	27
→ Le design de l'évaluation	28
→ Échantillon et limites	32
RÉSULTATS	37
→ Quel est l'impact des solutions envoyées ?	38
→ Comment les solutions ont-elles été utilisées ?	41
CONCLUSION	49



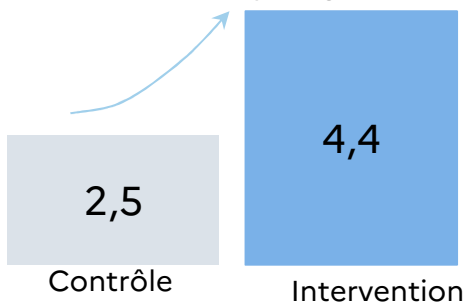
INTRODUCTION



Résumé

RÉSULTATS PRINCIPAUX

+ 76% de dépistages réalisés



2 femmes de plus
dépistées chaque
semaine grâce aux
solutions

7,9%
(Intervention)

4,6%
(Contrôle)

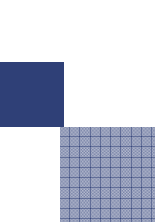
Proportion de patientes dépistées
chaque semaine

Deux solutions ont été testées :

La recommandation simplifiée est particulièrement appréciée pour ses conseils pratiques qui donnent des astuces aux MG pour dépister sans froisser leurs patientes et sa liste d'accompagnements à proposer aux personnes victimes et peut être diffusé largement.



Le questionnaire de prévention a été moins utilisé que la recommandation car il requiert plus d'efforts et de temps de la part du médecin et de la patiente. Il n'est donc pas recommandé de le diffuser à grande échelle.



Contexte de l'étude

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE ESSENTIEL

Les violences au sein du couple sont un phénomène difficile à quantifier, mais tous s'accordent pour dire qu'il est d'une ampleur inacceptable, faisant de leur réduction un enjeu de politique et de société prioritaire.

- D'après l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, près d'une femme sur 10 ayant vécu en couple pendant l'année écoulée a été en situation de violences conjugales au cours des 12 derniers mois ([Jaspard et al. 2003](#)).
- Ces violences ont des conséquences à court, moyen et long terme sur la vie des femmes (et des répercussions considérables sur les enfants) ([World Health Organization 2013](#)). Selon la Banque mondiale, les viols et violences conjugales représentent un risque plus grand pour une femme de 15 à 44 ans que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme réunis ([Venis & Horton, 2002](#)). De plus, le fait d'avoir subi des violences sexuelles multiplie par 26 le risque de faire une tentative de suicide ([Jaspard & Saurel-Cubizolles, 2003 cité](#)).
- En France, le coût global des violences conjugales est estimé à 2,5 milliards d'euros par an, dont 20% sont alloués aux soins médicaux ([Nectoux et al. 2010](#)).

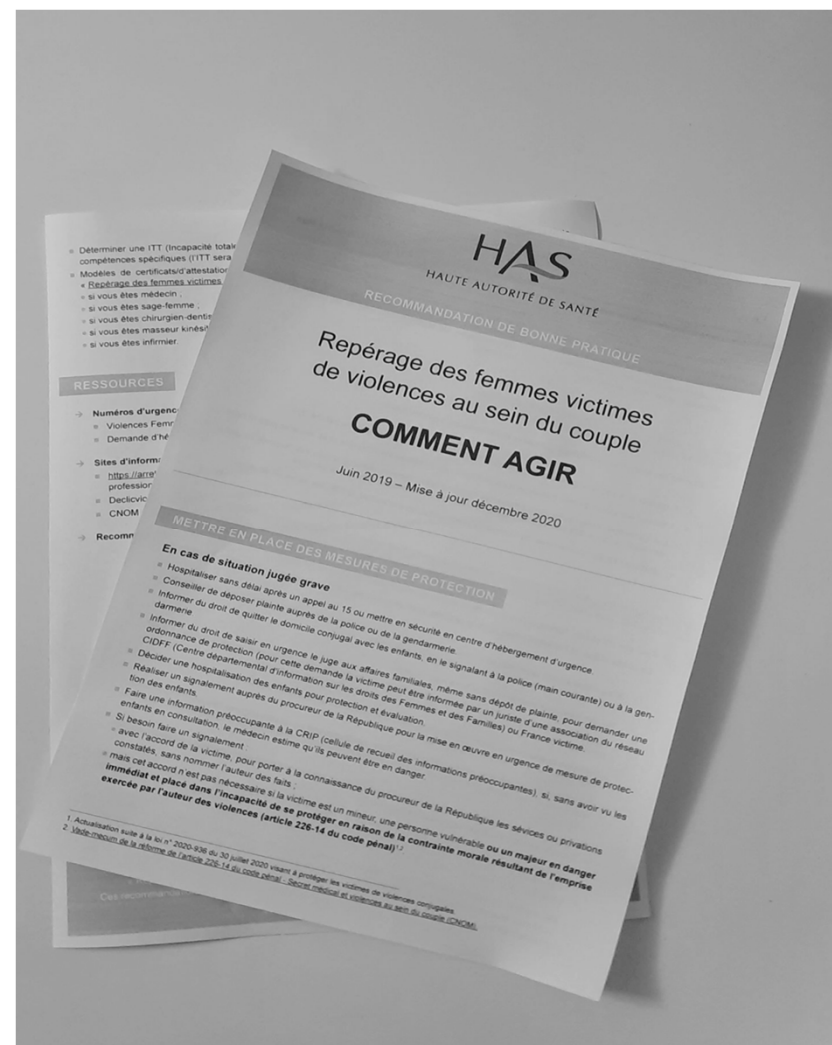


AMÉLIORER LE REPÉRAGE DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

En 2019, la HAS a publié [une recommandation de bonne pratique](#) visant à renforcer l'implication des professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues, psychiatres, etc.) dans la lutte contre les violences et à favoriser le repérage (ou dépistage) des femmes victimes de violences au sein du couple.

La Commission Impact des Recommandations (CIR) de la HAS, qui a pour mission d'améliorer la mise en œuvre, l'impact et le suivi des recommandations, a porté son attention sur cette recommandation. Elle a choisi, dans un premier temps, de se focaliser sur les médecins généralistes (MG) et sur l'un des messages clés de la recommandation: **« questionner systématiquement toutes les femmes sur d'éventuelles violences subies lors de l'anamnèse, même en l'absence de signe d'alerte ».**

La CIR a mené de nombreux travaux auprès de médecins généralistes (notamment une enquête quantitative en 2019 et une enquête qualitative en 2020) pour mieux comprendre les perceptions, les croyances et les attitudes des MG vis-à-vis de l'enjeu des violences conjugales et à identifier les principaux obstacles à la bonne application de cette recommandation.



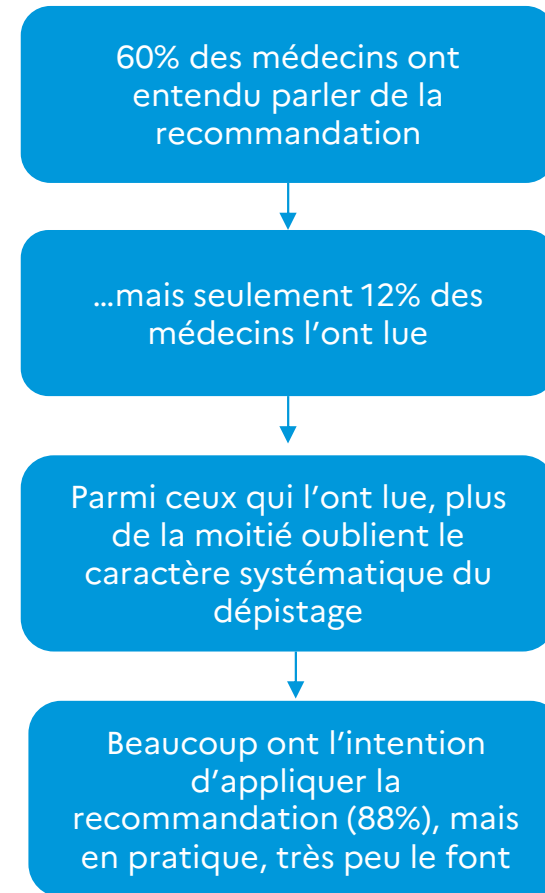
LE RÔLE DE L'APPROCHE COMPORTEMENTALE

À la suite de ces études, la CIR a fait le choix de solliciter une équipe d'experts en sciences comportementales de la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP) pour améliorer l'impact de la recommandation.

La DITP a également sollicité l'appui et l'expertise du Behavioural Insights Team (BIT) pour appliquer les leçons des sciences comportementales à ce domaine.

Les sciences comportementales constituent un ensemble de disciplines, théories et modèles qui visent à mieux comprendre le fonctionnement du comportement humain et les mécanismes de prise de décision individuelle et à favoriser le changement de comportement.

Dans le cadre de cette étude, un diagnostic comportemental a été effectué et un rapport de solutions a été publié. Ce rapport propose des solutions qui pourraient améliorer l'attention et l'intérêt portés à la recommandation, favoriser sa mémorisation et lever les freins comportementaux liés à l'environnement, aux capacités ou à la motivation des médecins généralistes.



Source : Imago (2019) Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple : impact et perception de la recommandation HAS en médecine générale



DIAGNOSTIC COMPORTEMENTAL

ACTIVITÉS MENÉES POUR RÉALISER LE DIAGNOSTIC

Nous présentons ici les activités de recherche que nous avons menées pour identifier les freins qui empêchent les médecins généralistes de questionner les femmes, et les leviers qui peuvent être utilisés pour favoriser un repérage systématique.



Recherche documentaire

- **Revue de la littérature** comportementale, académique et grise, portant sur les pratiques de prévention (y compris sur les violences conjugales)
- **Revue documentaire** des travaux réalisés par la HAS et des outils, supports et actions existants pour encourager le dépistage (notamment ceux réalisés par la MIPROF)



Recherche qualitative

- **Deux observations** en cabinet de généraliste et en maison de santé
- **Six entretiens qualitatifs semi-structurés** avec des MG, des professionnels de santé engagés sur le sujet (médecins légistes, gynécologues) et des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
- **Deux ateliers de co-création** avec des MG, la HAS, des designers et des graphistes



Synthèse

- Création d'un **modèle comportemental synthétique**
- **Catégorisation et priorisation des freins** principaux au repérage
- **Identification de leviers prometteurs**
- Élaboration d'une longue **liste de solutions** inspirées de nos entretiens et découlant du diagnostic

LES FREINS COMPORTEMENTAUX QUI EMPÊCHENT LE REPÉRAGE SYSTÉMATIQUE

Afin de classer les freins au repérage systématique, nous avons utilisé le modèle COM-B qui a été développé par un consensus de scientifiques spécialisés dans le changement de comportement (Michie et al, 2011). Ce modèle stipule qu'il existe trois facteurs importants susceptibles d'influencer le comportement d'un individu : **ses capacités (C)** (physiques et psychologiques), **son environnement (O pour « opportunités »)** et **sa motivation (M)**. Pour provoquer un changement de comportement, il faudra donc modifier au moins l'un de ces facteurs. Nous résumons ci-dessous les sept barrières principales identifiées qui sont détaillées dans le rapport de solutions.

Capacités



Les MG ont-ils toutes les connaissances et compétences nécessaires pour questionner les femmes de manière systématique ?

- Un grand nombre de médecins ne connaissent pas la recommandation et/ou ne s'en rappellent pas.
- Les médecins sous-estiment parfois la prévalence des violences conjugales et méconnaissent l'éventail des violences.
- La grande majorité des médecins n'ont pas été formés et ne savent pas comment poser la question et/ou comment accompagner la femme en cas de violences.

Motivation



Les MG sont-ils suffisamment motivés pour questionner les femmes de manière systématique ?

- Certains médecins considèrent qu'ils n'ont pas de rôle à jouer dans le repérage.
- Certains médecins ont peur de dégrader leur relation avec leur patiente et/ou de faire des erreurs dans leur accompagnement.
- Certains médecins pensent qu'ils ne pourront changer la situation des femmes victimes de violences qu'ils identifient et/ou accompagnent.

Environnement



Est-ce que l'environnement physique et social du MG encourage le questionnement systématique ?

- Les médecins n'ont pas assez de temps pour intégrer le questionnement (et l'accompagnement qui peut s'ensuivre) lors de l'anamnèse.

LES SOLUTIONS

Une longue liste de solutions ayant vocation à lever les freins identifiés lors du diagnostic ont été proposées à la HAS. Ces solutions sont présentées en détail dans le rapport de solution et catégorisées en plusieurs types d'interventions (restructuration de l'environnement, communications, etc.). Les solutions choisies par l'équipe projet pour être développées sont présentées dans les slides suivants et sont indiquées en gras ci-dessous.



Restructuration de l'environnement et de l'architecture du choix

- Introduire une étape supplémentaire dans l'anamnèse
- Introduire des rappels à des moments opportuns
- **Demander à la patiente de remplir un questionnaire avant ou pendant la consultation** et / ou transformer l'environnement physique du cabinet



Formation et accompagnement

- Améliorer la formation des médecins
- Mettre en place des outils d'aide à l'accompagnement et aider le médecin à passer le relais



Communications

- **Fournir un résumé simple, attrayant et actionnable de la recommandation de la HAS**
- Mettre en place une campagne d'information grand public valorisant et normalisant le rôle des médecins



Incitations financières

- Introduire des incitations (ou compensations financières) (par exemple en créant un acte spécifique aux violences faites aux femmes ou par le biais d'un critère de la ROSP)



PRÉSENTATION DES SOLUTIONS DÉVELOPPÉES

LES SOLUTIONS RETENUES

Le choix des interventions a été fait en s'appuyant sur les éléments et critères suivants :

- le diagnostic et la sélection des barrières les plus importantes à adresser ;
- le potentiel d'impact de l'intervention ;
- la faisabilité de l'implémentation et de l'évaluation ;
- le potentiel de mise à l'échelle.



Les solutions qui ont été retenues sont les suivantes :

- Une recommandation simplifiée ;
- et un questionnaire de prévention.

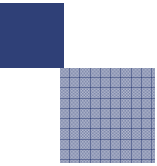
Une fois créées, ces solutions ont été envoyées par email aux participants. Cet email contenait lui-même des leviers comportementaux pour encourager l'ouverture du mail et la lecture de ces solutions.



Recommandation simplifiée

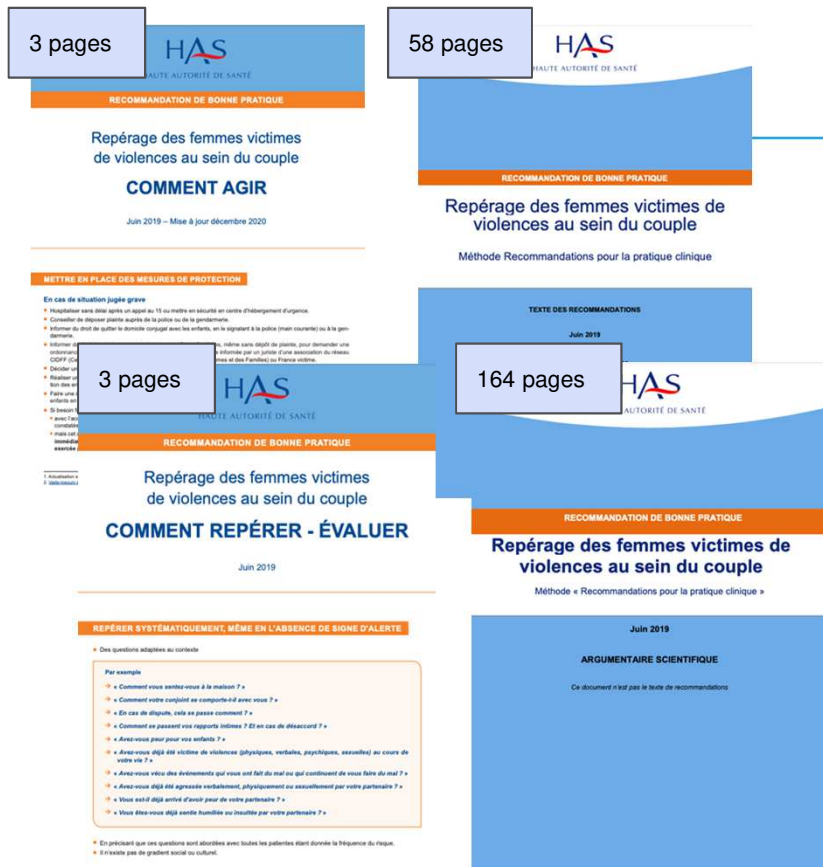


Questionnaire de prévention à destination des patientes



La recommandation simplifiée

LA RECOMMANDATION SIMPLIFIÉE



Freins identifiés

- Les médecins manquent de temps pour consulter les recommandations de la HAS (fiches pratiques, recommandation et argumentaire scientifique).
- 34% des médecins n'appliquent pas les recommandations préconisées à cause de la surcharge d'informations (Ipsos Public Affairs, 2020).

Leviers utilisés

- Résumer les informations essentielles en une seule page organisée en trois catégories distinctes (pourquoi repérer, comment questionner et comment réagir en cas de violences) pour alléger la charge cognitive des médecins et favoriser la mémorisation de la recommandation.
- Utiliser des images pour rendre le résumé attrayant et attirer l'attention des médecins

LA RECOMMANDATION SIMPLIFIÉE



Pourquoi dépister?

- **Vos patientes sont concernées :** sur 10 patientes vues, 3 à 4 femmes pourraient être victimes de violences conjugales¹.
- **En tant que médecin généraliste vous êtes les interlocuteurs privilégiés des femmes** et les premiers acteurs à qui elles s'adressent, devant la police et les associations².
- **Le dépistage systématique, ça marche :** vous avez 3 fois plus de probabilité de dépister des violences en posant directement la question³.
- **Les violences constituent un risque pour la santé de la femme** qui doit être évalué de manière systématique, indépendamment du milieu social, lors du parcours médical.



Freins identifiés

- Les médecins sous-estiment les violences de manière générale et chez leurs patientes et méconnaissent l'éventail des violences (Boismain & Gaudain, 2012). Pourtant, 37% des violences subies par les femmes sont d'ordre psychologique (Jaspard et al., 2003)
- Certains médecins pensent que leur rôle est curatif plutôt que préventif.



Leviers utilisés

- Personnaliser l'information pour les médecins généralistes ("vos patientes sont concernées") et corriger les perceptions faussées par le biais d'optimisme.
- Renforcer leur sentiment d'auto-efficacité et leur motivation en leur rappelant qu'ils sont un acteur privilégié des femmes et que le repérage fonctionne. La probabilité qu'un individu adopte un comportement dépend aussi du fait qu'il soit conscient des conséquences de son action (Schwartz, 1977).
- Rappeler que le repérage fait partie de leur rôle de médecin (en faisant référence à une identité positive). En effet, les médecins qui pensent qu'il est de leur responsabilité de dépister les abus sont 2 fois plus susceptibles de réaliser un repérage lors de la première consultation (Chamberlain & Perham-Hester, 2002).

LA RECOMMANDATION SIMPLIFIÉE



Quand et comment dépister?

Questionnez toutes vos patientes lors de l'anamnèse comme vous le faites pour les antécédents médicaux ou encore la consommation de tabac. N'hésitez pas à reposer la question ultérieurement en cas de grossesse ou de séparation.



Aborder le sujet peut vous paraître difficile. Vous pouvez :

- 1. Poser la question en vous aidant des exemples suivants** ou en les reformulant avec vos propres mots :
 - Comment ça se passe à la maison / avec votre partenaire ?
 - Pensez-vous avoir subi des violences (physiques, verbales, psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ?
- 2. Utiliser le questionnaire de prévention fourni**, en :
 - le mettant en libre-service dans votre salle d'attente ;
 - demandant à votre secrétaire de le distribuer ;
 - l'utilisant comme guide lors de la consultation.

8 femmes sur 10⁴ pensent qu'il est normal d'aborder ces questions avec son médecin. Pour normaliser cette conversation, vous pouvez préciser que vous abordez cette question avec toutes vos nouvelles patientes.



Freins identifiés

- Les médecins n'aiment pas le ton "paternaliste" et "descendant" des recommandations
- Ils ne savent pas comment questionner leurs patientes.
- Plus de la moitié des médecins qui ont lu la recommandation oublient son caractère systématique.
- Les médecins sont gênés de poser la question et se rappellent plus souvent des réactions négatives des patientes que des réactions neutres ou positives.



Leviers utilisés

- Proposer différentes manières de poser la question en adoptant un ton empathique et en laissant aux médecins la liberté de reformuler ces questions avec leurs propres mots.
- Répéter plusieurs fois dans le résumé simplifié que le repérage doit être systématique.
- Donner des conseils aux médecins sur la manière d'aborder le sujet, leur rappeler la norme sociale et les rassurer quant à la réaction possible des patientes (la majorité des femmes sont favorables au repérage).

LA RECOMMANDATION SIMPLIFIÉE



Que faire en cas de violences ?

- **Écouter votre patiente de manière bienveillante**, lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que les faits de violences sont punis par la loi et qu'elle peut porter plainte.
- **Proposer un 2ème rendez-vous** pour en reparler et compléter le dossier médical avec vos observations.
- **Rediriger votre patiente vers des spécialistes** de votre réseau qui pourront l'accompagner. Voir section « **Proposer un accompagnement** », ci-contre.

Proposer un accompagnement

Médical / psychologique

- Unité médico-judiciaire
- Psychologue, psychiatre
- Pédiatre (si enfants présents)

Social

- **115** : Hébergement d'urgence
- Associations (liste sur arreteonslesviolences.gouv.fr)

Judiciaire

- **17** : Gendarmerie, police
- Accès au droit et informations juridique : fncidff.info

En cas de doute consultez decliviolence.fr, le **3919, ou appelez le **3919**, une ligne est dédiée aux professionnels de santé.**

1. decliviolence.fr 2. Haute Autorité de Santé (2019). Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. Argumentaire scientifique. Saint-Denis La Plaine. 3. O'Doherty, L., Hegarty, K., Ramsay, J., Davidson, L., Feder, G., & Taft, A. (2019). Screening women for intimate partner violence in healthcare settings. Cochrane database of systematic reviews. 4. Palisse, M. (2013). Repérage par le médecin généraliste des violences sexuelles faites aux femmes : le point de vue des patientes. Médecine humaine et pathologie.



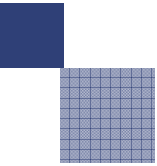
Freins identifiés

- Les médecins ne posent pas la question par peur de devoir passer plus de temps en consultation en cas de dépistage positif.
- Les médecins ne savent pas comment réagir en cas de dépistage positif (par exemple, ce qu'ils doivent dire ou comment accompagner la patiente).
- Ils pensent qu'ils doivent gérer cette situation seuls.



Leviers utilisés

- Rappeler aux médecins les étapes à suivre en cas de dépistage positif et leur proposer de reprendre un second rendez-vous s'ils n'ont pas eu le temps d'aborder le sujet en profondeur avec la patiente.
- Catégoriser les types d'accompagnements possibles et fournir des informations utiles (numéros, sites internet, etc.) pour les femmes et pour les médecins eux-mêmes.
- Rassurer les médecins en leur rappelant qu'ils peuvent référer la patiente à des spécialistes.



Le questionnaire de prévention

LE QUESTIONNAIRE DE PRÉVENTION

La deuxième solution développée est un questionnaire de prévention qui a été pensé pour être utilisé de deux manières différentes :

- Les médecins peuvent l'utiliser comme un guide lors de la conversation (en réutilisant les questions sur les violences conjugales) ;
- ou le placer en salle d'attente / demander à leur secrétaire de le distribuer aux patientes avant la consultation. Dans ce cas, le document doit être imprimé et plié avant d'être distribué (voir la photo ci-contre).

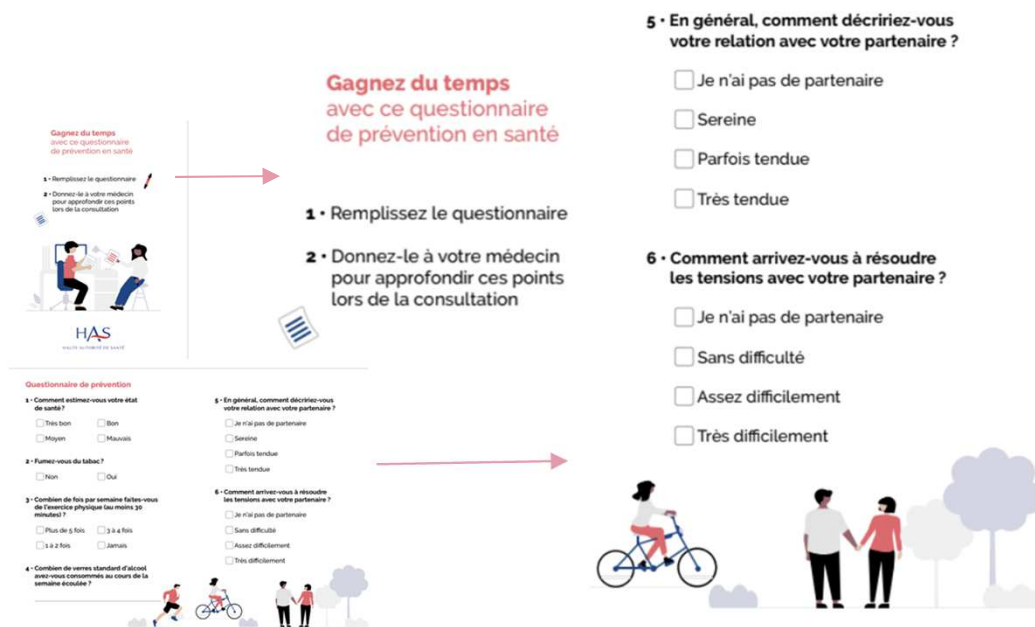
La présence de ce support d'informations a pour but de favoriser la démarche de révélation ([Société scientifique de médecine générale & Agence pour une meilleure qualité de vie, 2018](#)).



Questionnaire de prévention pliable



LE QUESTIONNAIRE DE PRÉVENTION



Les questions sur les violences conjugales sont inspirées de la version courte de l'outil de dépistage WAST qui a été testé et validé en France (Guiget-Auclair et al, 2021) et à l'étranger (McCord-Duncan et al, 2006). Ce questionnaire a été choisi car il est accepté par 95% des femmes et apprécié des professionnels de santé.



Freins identifiés

- Les médecins disent manquer de temps pour aborder le sujet des violences.
- Ils sont gênés d'évoquer ce sujet avec leurs patientes.



Leviers utilisés

- Si le questionnaire est rempli par la patiente avant la consultation et rendu au médecin lors de la consultation, il peut faire gagner du temps au médecin en lui fournissant des informations pertinentes qu'il peut choisir d'approfondir (ou non).
- Certaines femmes préfèrent remplir un questionnaire plutôt que de se voir poser la question directement (O'Doherty et al., 2015; Phelan, 2007).

LE QUESTIONNAIRE DE PRÉVENTION

Gagnez du temps avec ce questionnaire de prévention en santé.

1 - Remplissez le questionnaire
2 - Donnez-le à votre médecin pour approfondir ses points forts de la consultation

Questionnaire de prévention

1 - Comment estimez-vous votre état de santé ?
☐ Très bon ☐ Bon
☐ Moyen ☐ Mauvais

2 - Fumez-vous du tabac ?
☐ Non ☐ Oui

3 - Combien de fois par semaine faites-vous de l'exercice physique (au moins 30 minutes) ?
☐ Plus de 5 fois ☐ 3 à 4 fois
☐ 1 à 2 fois ☐ Jamais

4 - Combien de verres standard d'alcool avez-vous consommés au cours de la semaine écoulée ?

5 - En général, comment décrivez-vous votre relation avec votre partenaire ?
☐ Je n'ai pas de partenaire
☐ Serène
☐ Parfois tendue
☐ Très tendue

6 - Comment arrivez-vous à résoudre les tensions avec votre partenaire ?
☐ Je n'ai pas de partenaire
☐ Sans difficulté
☐ Assez difficilement
☐ Très difficilement

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ



Remarques sur le questionnaire de prévention :

S'il est mis en libre accès en salle d'attente, le questionnaire de prévention permet de fournir des outils à la patiente pour qu'elle puisse obtenir une aide, avec ou sans l'aide du médecin.

Le sujet des violences conjugales est abordé au même titre que l'exercice physique ou la consommation de tabac et d'alcool pour deux raisons principales :

- normaliser le sujet comme un sujet de santé publique ;
- protéger les femmes (si le conjoint violent les accompagne ou s'il trouve le questionnaire dans leurs affaires).

LES EMAILS ENVOYÉS

Les solutions ont été envoyées aux MG par email (avec une relance leur rappelant de les utiliser). Ces emails constituent des rappels et contiennent des leviers comportementaux susceptibles d'améliorer l'impact de la recommandation simplifiée et du questionnaire.



Leviers utilisés pour encourager l'utilisation des solutions

- Rendre l'email attrayant en intégrant une image au texte
- Utiliser le logo de la HAS pour renforcer l'effet messenger : les médecins sont plus susceptibles d'agir sur des informations qui sont communiquées par un acteur crédible et respecté tel que la HAS
- Personnaliser l'information aux médecins généralistes en s'adressant directement à eux ("Médecins généralistes") et en soulignant le rôle important qu'ils jouent dans le repérage des violences
- Utiliser des normes sociales descriptives en rappelant aux médecins que la majorité des médecins généralistes ont entendu parler de la recommandation de la HAS.
- Signer l'email avec le nom d'une personne identifiable pour diminuer la sensation que l'email serait un email groupé

Objet : Vos solutions pour repérer les victimes de violence sont disponibles !



Médecins généralistes, aidez-nous à améliorer le repérage des victimes de violences

Bonjour,

Merci encore pour votre inscription à l'étude visant à améliorer le repérage des patientes victimes de violences conjugales.

La majorité des médecins généralistes ont entendu parler de la [recommandation de la Haute Autorité de santé \(HAS\)](#) sur le questionnement systématique des patientes lors de l'anamnèse pour identifier si elles vivent (ou ont vécu) des violences. Cependant, ils souhaitent plus d'outils "clés en main" pour mieux appliquer cette recommandation.

Nous avons donc conçu deux outils pour vous aider à repérer et à accompagner vos patientes :

- **Un résumé simplifié de la recommandation de la HAS**, d'une seule page, pour savoir pourquoi et comment dépister les violences au sein du couple (et accompagner vos patientes si besoin est).
- **Un outil d'appui au dialogue, sous la forme d'un questionnaire de prévention**. Cet outil est optionnel, il vise à vous faire gagner du temps. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser pendant la consultation ou le laisser en accès libre dans votre salle d'attente. *Petite astuce : il devient un petit carnet s'il est plié en 4 !*

[Voir le résumé simplifié](#) [Voir le questionnaire de prévention](#)

Nous vous invitons à utiliser ces solutions au cours des six prochaines semaines. Nous vous recontacterons ensuite pour recueillir vos retours sur ces documents par le biais d'une enquête flash.

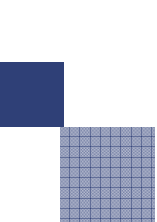
Pour assurer la validité et la robustesse de cette étude, nous vous demandons de ne pas partager ces outils avec vos confrères/sœurs.

Merci infiniment pour votre participation,

Anysia de l'équipe projet



CONCEPTION DE L'ÉVALUATION



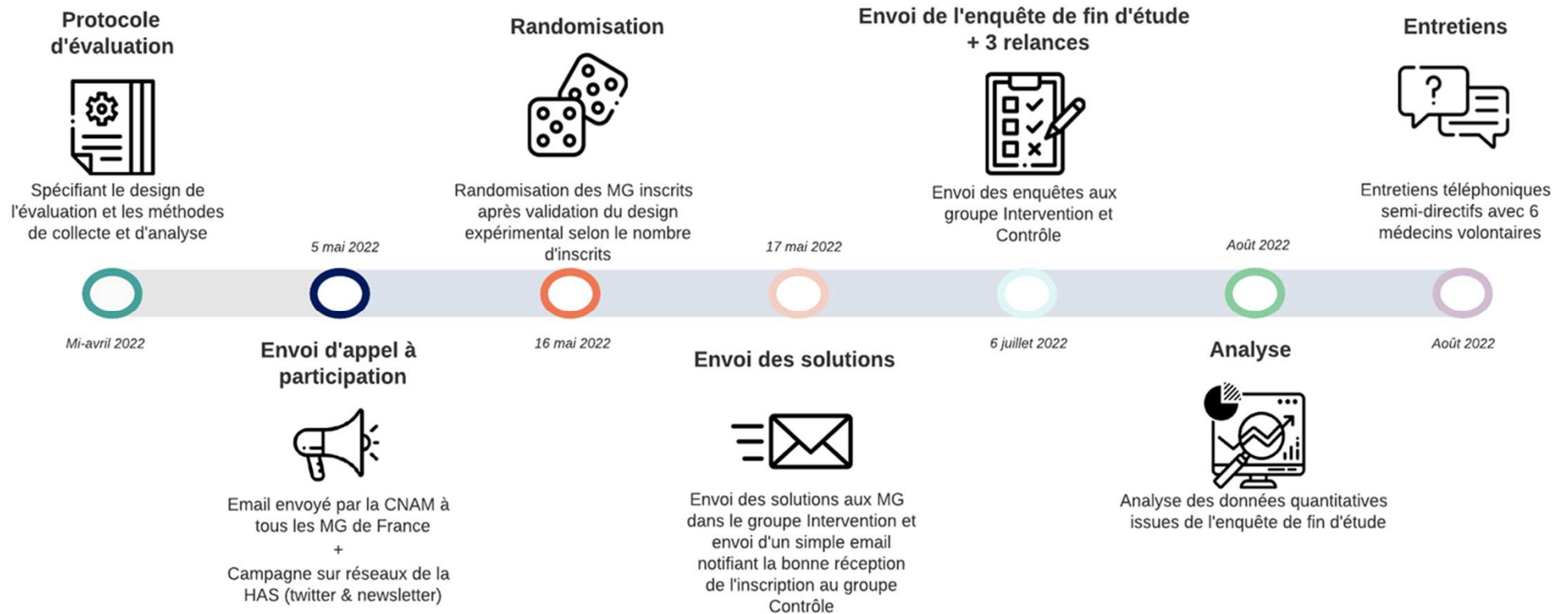
Le design de l'évaluation

OBJECTIFS ET MESURES DE RÉSULTATS

Une expérimentation a été menée pour mesurer l'impact des solutions et évaluer leur mise en œuvre (prise en main, utilisation faite, adaptations réalisées). Les données ont été collectées grâce à une combinaison d'enquête de fin d'étude et d'entretiens qualitatifs de suivi.

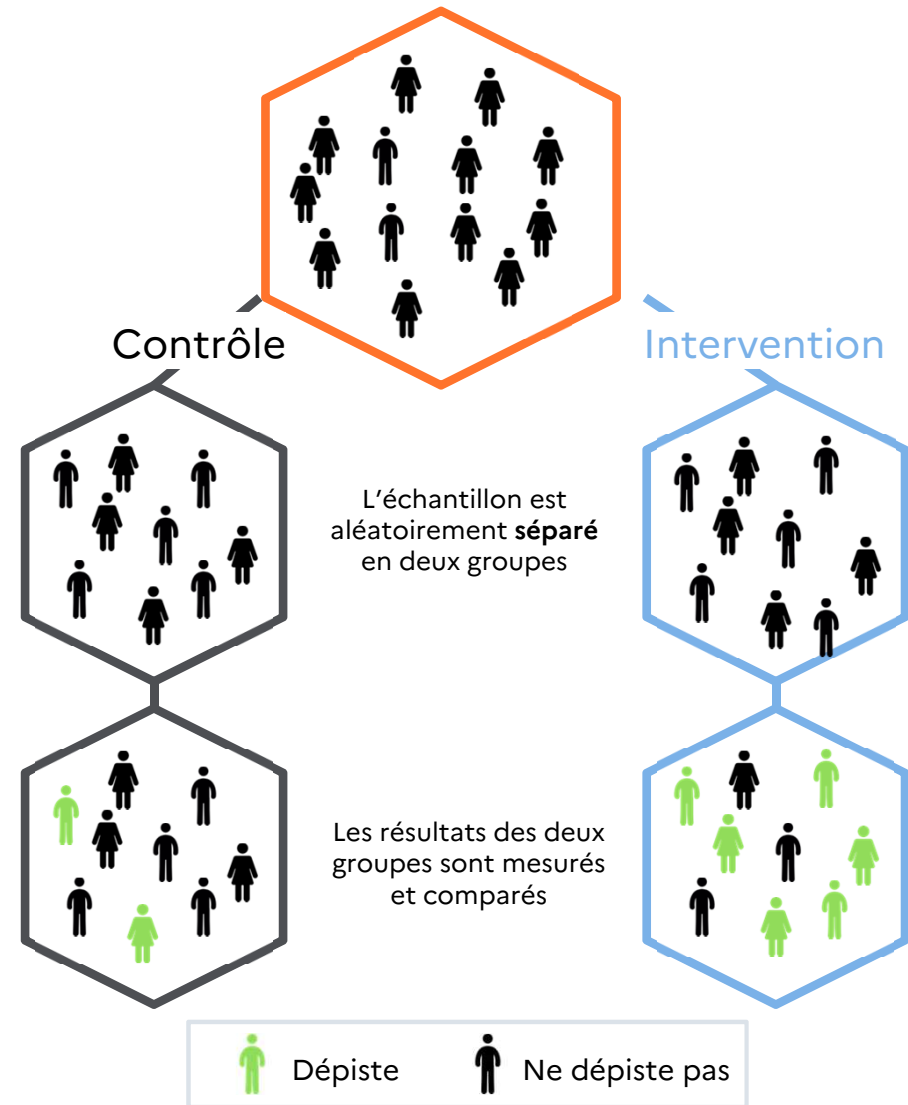
Questions de recherche	Mesures collectées
Évaluation d'impact	
L'utilisation des solutions augmente-t-elle le nombre de questionnements réalisés sur les violences conjugales ?	Enquête de fin d'étude : - Nombre de questionnements réalisés la dernière semaine ouvrée - Perception de l'évolution de la fréquence de dépistage.
L'utilisation des solutions augmente-t-elle l'aisance avec laquelle les MG dépistent pour violences conjugales ?	Enquête de fin d'étude : - Aisance avec laquelle les MG interrogent leurs patientes à propos des violences conjugales
Évaluation de l'efficacité de la mise en oeuvre	
- Comment les solutions ont-elles été utilisées ? Les médecins ont-ils réalisé des adaptations ? - Quelles sont les barrières à l'utilisation des solutions ? - Quels leviers pourraient être utilisés pour inciter les médecins dans l'utilisation des solutions ?	Enquête de fin d'étude : - Façon dont les solutions ont été utilisées (imprimées, mises à disposition en salle d'attente ou utilisées comme guide de discussion) Entretiens qualitatifs : - Barrières à l'utilisation ; - Adaptations faites et suggestions d'amélioration.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L'ÉVALUATION



DESIGN EXPÉRIMENTAL

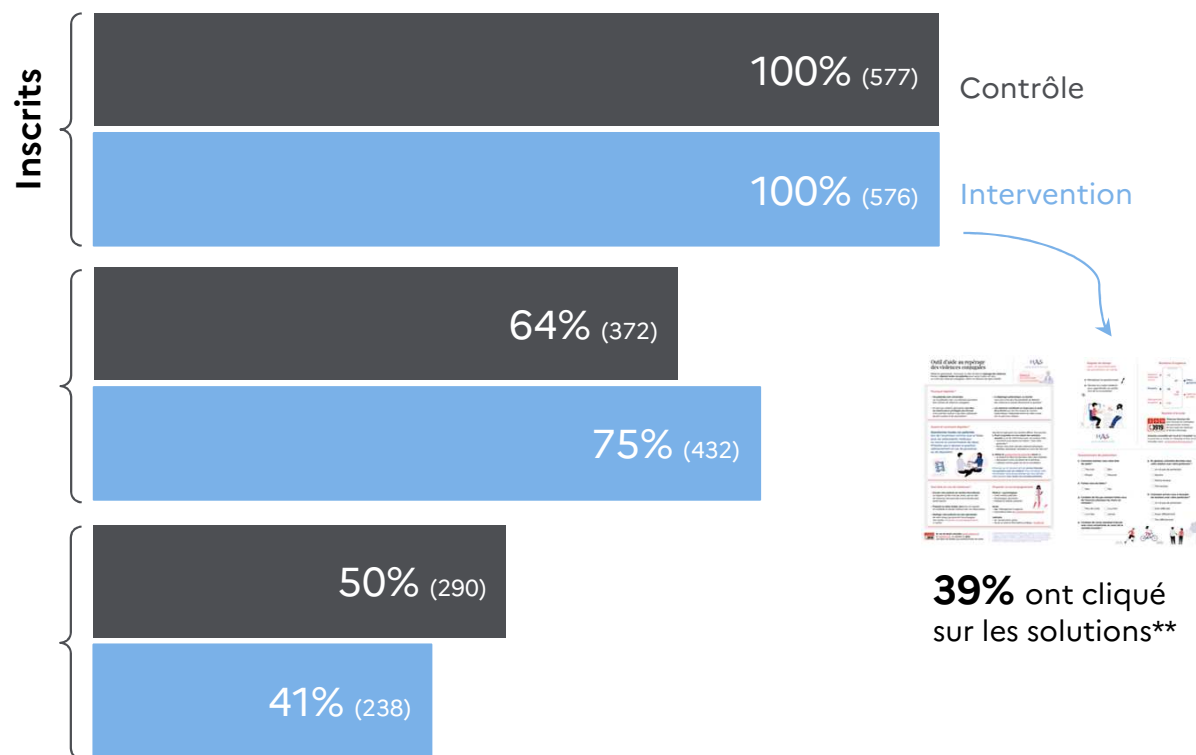
- Les participants ont été recrutés grâce à un email envoyé par le médecin conseil de l'Assurance Maladie à l'ensemble des médecins généralistes exerçant en France.
- Grâce à cette campagne de recrutement, 1153 médecins généralistes se sont inscrits à cette expérimentation.
- Afin d'évaluer l'efficacité des solutions créées, un essai contrôlé randomisé (ECR) a été mis place. L'échantillon de 1153 médecins inscrits a été divisé de manière aléatoire en deux groupes : le groupe Intervention qui a reçu les solutions proposées et le groupe Contrôle qui n'a reçu aucune solution.
- Cette méthode représente une référence pour l'évaluation d'impact. Contrairement à d'autres méthodes d'évaluation, elle permet d'isoler l'effet d'une intervention de celui d'autres facteurs (individuels, contextuels ou temporels) grâce à la formation aléatoire d'un groupe témoin et d'établir des liens de causalité entre l'intervention et les résultats observés.





Échantillon et limites

LA MAJORITÉ DES MÉDECINS ONT OUVERT LES EMAILS ENVOYÉS MAIS SEULEMENT 4 MÉDECINS SUR 10 ONT TÉLÉCHARGÉ LES SOLUTIONS



* Un MG est considéré comme une personne qui a ouvert les mails, si il / elle a ouvert au moins un des mails envoyés par le BIT et contenant les solutions (pour le groupe Intervention) ou confirmant l'inscription (pour le groupe contrôle)

** Base : les médecins inscrits dans le groupe Intervention

- Les emails contenant les solutions (groupe Intervention) ou confirmant l'inscription (groupe Contrôle) ont été envoyés aux MG.
- Les taux d'ouverture (69% en moyenne) sont relativement élevés. La HAS a un taux d'ouverture d'environ 40% pour sa newsletter (la newsletter a des taux d'ouverture légèrement plus élevés que d'autres e-mails HAS, qui eux se situent généralement entre 30% et 40%) . Environ 4 MG sur 10 (39%) dans le groupe Intervention ont cliqué sur le lien leur permettant de télécharger les solutions. Cette déperdition est probablement due au changement de plateforme.
- Dans une mise à l'échelle, proposer les solutions directement dans le corps du mail, en pièce jointe ou par envoi postal plutôt que de demander de 'changer' de plateforme en cliquant sur les liens avant d'accéder aux solutions pourrait améliorer la probabilité d'accéder aux solutions.

L'ÉCHANTILLON EST MAJORITAIREMENT FÉMININ ET PLUS JEUNE QUE LA MOYENNE NATIONALE

- En comparant les statistiques des médecins participants aux statistiques nationales, on observe que l'échantillon se distingue légèrement, car il inclut plus de femmes et de jeunes médecins. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les femmes, surtout celles plus jeunes, semblent plus intéressées par ce sujet (Ifop, 2020).
- Les médecins de l'échantillon voient par ailleurs légèrement moins de femmes que la population générale des MG par jour.

Caractéristiques professionnelles



14% FR 39%
Seul.e



32%
Maison
pluriprofessionnelle



52% FR 57%
Cabinet partagé

[Drees \(2020\)](#)



1%
Milieu
hospitalier



4
Jours ouverts
/ semaine en
moyenne



14 FR 22
patientes /
jour en
moyenne

[Doctolib \(2017\)](#)

Caractéristiques démographiques

70% FR 50%
Femmes

[Drees \(2022\)](#)



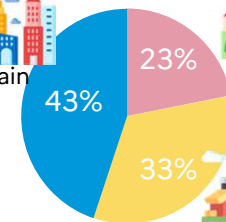
Urbain



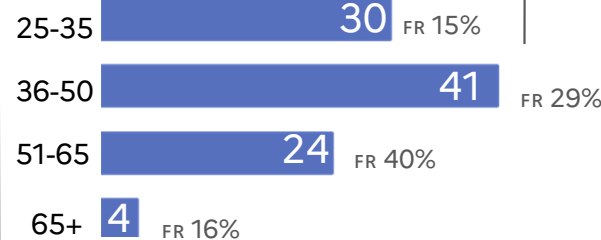
Péri-
urbain



Rural



Âge (%)



[Drees \(2022\)](#)

Données collectées en été 2022. Analyse réalisée sur les 1153 participants inscrits à l'étude.
Lorsqu'elle est disponible, la moyenne française est donnée sur la droite de la statistique provenant de notre étude.

SEUL UN MÉDECIN SUR SIX UTILISE ACTUELLEMENT DES OUTILS POUR FACILITER LE REPÉRAGE ET L'ACCOMPAGNEMENT

- L'enquête réalisée auprès des MG du groupe Contrôle est utile pour mieux comprendre la proportion d'entre eux qui utilisent des outils et les outils couramment utilisés par les médecins pour repérer les violences conjugales.
- Selon l'enquête, seul **1 médecin sur 6** (17%) (dans le groupe Contrôle) utilise actuellement des outils pour aider dans le repérage. Parmi eux, **84% s'en disent satisfaits**.
- Ils apprécient tout particulièrement les sites internet qui leur permettent de trouver des associations ou ressources locales ou encore des outils qu'ils peuvent utiliser avec les femmes (violentomètre) ou distribuer directement (plaquettes d'informations).
- Les MG déplorent néanmoins les outils jugés trop longs à lire ou difficiles à mettre en place, des ressources qui ne sont pas assez fréquemment mises à jour, ou encore les faiblesses d'un réseau d'intervenants qui manquent de ressources pour accueillir et accompagner les femmes.



Points forts

Des outils complets

« [les sites comme declicviolences.fr ou arretonslesviolences.fr] sont complets et exhaustifs, il y a beaucoup d'infos dispo au même endroit »

« Les plaquettes du 3919 distribuées par la préfecture contiennent les adresses des acteurs locaux, ça répond au besoin des femmes pour les accompagner dans leur parcours de femmes victimes de violences »

Des outils faciles à comprendre

« [le violentomètre] a des visuels simples et est facile d'utilisation, c'est très parlant pour graduer les violences »



Points faibles

Des outils peu adaptés

« [WAST] est un peu long »

« [La recommandation HAS] n'est pas spécifique et la mise en pratique est difficile »

« L'annuaire des associations n'est pas à jour. »

Une faiblesse du réseau

« Asso locale top mais débordée »

« Les interlocuteurs renvoient vers le médecin généraliste et rien d'autre »

« Peu de solutions effectives sont proposées »



Violentomètre



Capture d'écran du site declicviolence.fr

LIMITES DE L'ÉTUDE

Les limites méthodologiques de l'étude font des résultats présentés plus bas une estimation potentiellement optimiste de l'effet à attendre en cas de mise à l'échelle. Parmi ces limites, considérées dans l'interprétation présentée, on compte :

- **Biais de sélection** : les MG volontaires qui se sont inscrits sont potentiellement plus sensibilisés que le médecin moyen. De surcroît, ceux qui ont répondu à l'enquête de fin d'étude représentent un sous-échantillon probablement encore plus motivé et impliqué. Cela n'affecte pas la validité interne des résultats puisque ce biais concerne les groupes de Contrôle et d'Intervention. Cependant, il est probable qu'en cas de mise à l'échelle, les effets mesurés se maintiennent pour les médecins motivés, mais soient en moyenne atténués.
- **Mesures auto-rapportées** : les mesures ont été collectées grâce à une enquête en ligne car il n'existe pas de mesures administratives sur ce sujet. Elles sont donc toutes auto-rapportées et peuvent être biaisées, par la mémoire des médecins, ou encore par leur volonté de se présenter sous un angle favorable (**biais de désirabilité**).
- **Attrition** : 46% des médecins inscrits ont répondu à l'enquête de fin d'étude. Ces derniers ne diffèrent pas de ceux n'ayant pas répondu sur des critères démographiques et professionnels comme leur sexe, âge ou le type de cabinet. Seuls les MG recevant un peu plus de patientes étaient moins susceptibles de répondre à l'enquête, probablement par manque de temps. Le taux de réponse est plus élevé dans le groupe Contrôle (50%) que dans le groupe Intervention (41%). Cependant, les médecins du groupe Contrôle ne diffèrent pas significativement de ceux du groupe Intervention sur les critères observés. Cette attrition différentielle n'affecte donc pas la validité des comparaisons.

RÉSULTATS



**Quel est l'impact des
solutions envoyées ?**

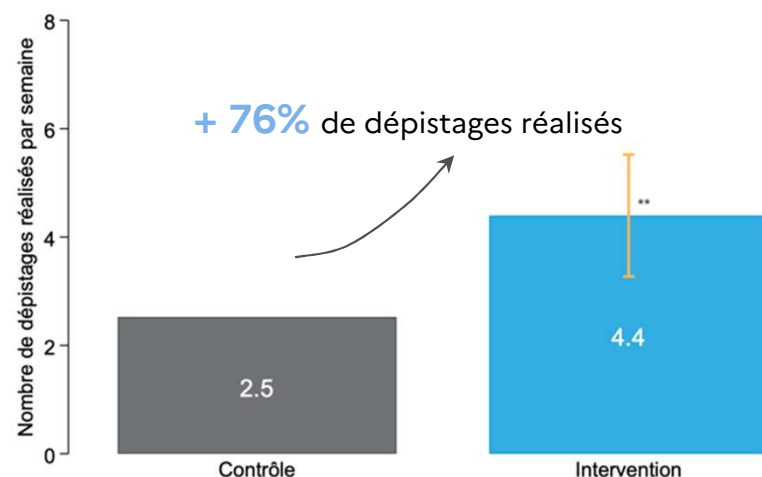
LES MÉDECINS AYANT REÇU LES SOLUTIONS QUESTIONNENT DEUX FEMMES DE PLUS PAR SEMAINE

Constats

- Les médecins ayant reçu la recommandation simplifiée et le questionnaire de prévention questionnent en moyenne deux femmes de plus par semaine. Ils sont également plus nombreux (27% contre 16% dans le groupe Contrôle) à déclarer une augmentation de la fréquence de dépistage dans leur pratique.
- Cette augmentation est importante et encourageante. Les femmes questionnées restent toutefois une minorité : entre 4,5% et 8% des patientes vues, respectivement dans les groupes Contrôle et Intervention*.
- Les solutions fournies permettent donc d'encourager les médecins à dépister plus souvent, mais pas encore de manière systématique.
- Le nombre moyen de femmes identifiées comme étant victimes de violences est de 1 patiente par semaine par médecin. Ce nombre ne varie pas entre les groupes de Contrôle et d'Intervention, sans surprise : déclarer des violences demande le temps de bâtir une relation de confiance avec le médecin (MIPROF 2015). C'est pourquoi l'étude ne se focalisait pas sur cette mesure.

« Ça fait réfléchir le patient même si ça n'aboutit pas toujours dans la consultation qui suit. Ça peut être une graine semée pour plus tard » - MG2

Nombre de patientes questionnées pour violences conjugales la semaine précédente**



n = 522

** p < 0.01, * p < 0.05, + p < 0.1

Analyse primaire, contrôlant pour le genre, l'âge, le type de cabinet, le niveau d'urbanisation des MG et le nombre de jours ouvrés par semaine. Ces variables ne semblent pas augmenter sur la probabilité de questionner une patiente, mis à part le fait d'être une soi-même une femme.

* Chiffre basé sur les données collectées lors de l'inscription qui indiquent que les participants travaillent en moyenne 4 jours par semaine et voient en 14 femmes par jour

** Les analyses ne comprennent que 522 participants plutôt que 528 car 6 ont été exclus de l'analyse pour cause de réponses erronées

...MAIS MALGRÉ LES SOLUTIONS PROPOSÉES, LE SUJET DES VIOLENCES RESTE DIFFICILE À ABORDER

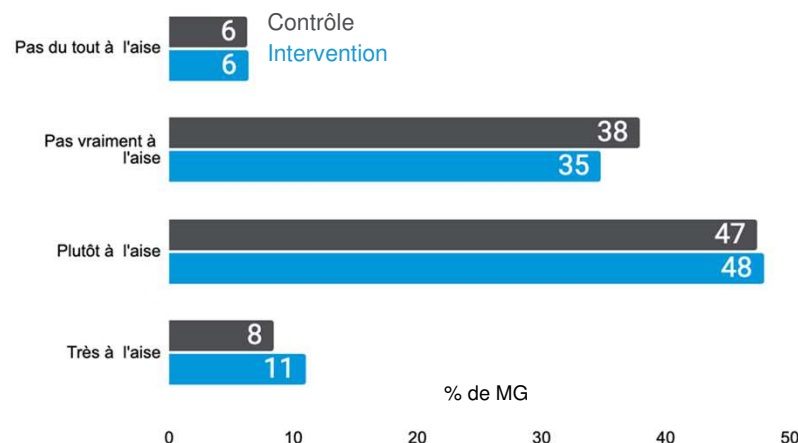
Constats

- **Plus de 4 médecins sur 10 rapportent ne pas être à l'aise avec le fait de questionner leurs patientes à propos des violences conjugales.** Ces taux sont similaires dans les deux groupes (Contrôle et Intervention), suggérant que les solutions ont eu peu d'effet sur l'aisance du questionnement.
- Les entretiens révèlent que les médecins sont souvent **découragés** après des expériences perçues comme « négatives » (par exemple si la patiente considère la question comme une intrusion dans sa vie privée, refuse de répondre et / ou change de médecin après la consultation). Certains d'entre eux préfèrent un **dépistage ciblé**, c'est-à-dire qu'ils ne posent la question qu'en cas d'alerte ou de symptômes particuliers (tels que des troubles psychologiques).

Recommandations

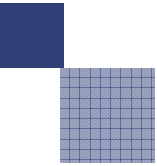
- **Prévenir les femmes** que le médecin peut être amené à les interroger à ce sujet **avant leur consultation** (par le biais d'un poster en salle d'attente par exemple) pourrait contribuer à réduire le nombre de réactions perçues comme « négatives » ainsi que la gêne des médecins.

Aisance des médecins à questionner leurs patientes à propos des violences conjugales*



« La question est pas bien prise, les patients étaient là juste pour soigner les symptômes et du coup ils changent de médecin si on leur pose la question [des violences] » - MG6

« Je dépistais quand j'étais remplaçant, mais j'ai trouvé que les gens le recevaient mal [...] j'ai trouvé ça délicat et j'ai arrêté de le faire » - MG5



**Comment les solutions
ont-elles été utilisées ?**

LA MAJORITÉ DES MG A LU LA RECOMMANDATION SIMPLIFIÉE ET L'A TROUVÉ UTILE ET PRATIQUE

Constats

- 2 médecins sur 3 (66%) ont lu la recommandation simplifiée. Les MG n'ayant pas lu la recommandation simplifiée déclarent ne pas l'avoir reçue (59%) ou avoir manqué de temps pour la consulter (37%), sans pour autant remettre en question la longueur de la recommandation, puisque des MG interrogés en entretien ont loué sa brièveté.
- Selon les médecins interrogés en entretien et ceux ayant répondu à l'enquête, les parties les plus utiles selon eux (en bleu) sont les conseils et outils à utiliser et les accompagnements à proposer.

Recommandations

- Les médecins suggèrent d'améliorer la recommandation en proposant des contacts locaux car ils sont souvent trop occupés pour rechercher ces informations eux-mêmes. En l'absence de numéros locaux, un espace blanc dédiés aux numéros locaux pourrait être ajouté.

« La dernière partie m'est utile, car je n'ai pas tous les numéros en tête et je ne connais pas toutes les associations et que parfois, il faut en connaître plusieurs. » - MG5

Le côté systématique du dépistage : 41%

Les conseils et outils à utiliser : 62%

Les étapes à suivre : 50%

Proportion de MG indiquant cette section comme utile

Outil d'aide au repérage des violences conjugales

Médecins généralistes, vous jouez un rôle-clé dans le repérage des violences. Pensez à **dépister toutes vos patientes** pour savoir si elles ont vécu ou vivent des violences conjugales, même en l'absence de signe d'alerte.

[Cliquez ici pour télécharger la recommandation](#)

Pourquoi dépister ?

- Vos patientes sont concernées : sur 10 patientes vues, 3 à 4 femmes pourraient être victimes de violences conjugales¹.
- En tant que médecin généraliste vous êtes les interlocuteurs privilégiés des femmes et les premiers acteurs à qui elles s'adressent, devant la police et les associations².
- Le dépistage systématique, ça marche : vous avez 3 fois plus de probabilité de dépister des violences en posant directement la question³.
- Les violences constituent un risque pour la santé de la femme qui doit être évalué de manière systématique, indépendamment du milieu social, lors du parcours médical.

Quand et comment dépister ?

Questionnez toutes vos patientes lors de l'anamnèse comme vous le faites pour les antécédents médicaux ou encore la consommation de tabac. N'hésitez pas à reposer la question ultérieurement en cas de grossesse ou de séparation.

Aborder le sujet peut vous paraître difficile. Vous pouvez :

- Poser la question en vous aidant des exemples suivants** ou en les reformulant avec vos propres mots :
 - Comment ça se passe à la maison / avec votre partenaire ?
 - Pensez-vous avoir subi des violences (physiques, verbales, psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ?
- Utiliser le questionnaire de prévention** fourni, en :
 - le mettant en libre-service dans votre salle d'attente;
 - demandant à votre secrétaire de le distribuer;
 - l'utilisant comme guide lors de la consultation.

8 femmes sur 10⁴ pensent qu'il est normal d'aborder ces questions avec son médecin. Pour normaliser cette conversation, vous pouvez préciser que vous abordez cette question avec toutes vos nouvelles patientes.

Que faire en cas de violences ?

- Écouter votre patiente de manière bienveillante, lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que les faits de violences sont punis par la loi et qu'elle peut porter plainte.
- Proposer un 1^{er} rendez-vous pour en reparler et compléter le dossier médical avec vos observations.
- Rediriger votre patiente vers des spécialistes de votre réseau qui pourront l'accompagner. Voir section « Proposer un accompagnement », ci-contre.

Proposer un accompagnement

Médical / psychologique

- Unité médico-judiciaire
- Psychologue, psychiatre
- Pédiatre (si enfants présents)

Social

- 115 : Hébergement d'urgence
- Associations (liste sur arretonslesviolences.gouv.fr)

Judiciaire

- 17 : Gendarmerie, police
- Accès au droit et informations juridique : fncidf.info

En cas de doute consultez declicviolence.fr, le vademecum, ou appelez le 3919, une ligne est dédiée aux professionnels de santé.

Les statistiques : 48%

Les accompagnements à proposer : 69%

Les étapes à suivre : 50%

Les conseils et outils à utiliser : 62%

Le côté systématique du dépistage : 41%

LA RECOMMANDATION SIMPLIFIÉE A CRÉÉ UN ÉLAN DE MOTIVATION PARMİ LES MÉDECİNS

Constats

D'après les entretiens, la recommandation simplifiée a agi de plusieurs manières :

- Elle a permis à certains médecins de **prendre conscience de la recommandation** (soulignant l'importance de la diffusion large d'un résumé simple et court).
- Elle a servi de **rappel sur le caractère systématique du dépistage** (y compris chez les patientes existantes, pas seulement chez les nouvelles patientes).
- Elle a permis **de rassurer et de conforter certains médecins dans leurs pratiques** et de renforcer leur motivation à réaliser un dépistage.
- Elle a permis de **développer une meilleure connaissance des types d'accompagnements à proposer** aux patientes victimes de violences, et a également incité certains médecins à rechercher des associations locales.

Recommandations

- Diffuser largement des recommandations simplifiées et attrayantes tenant sur un format A4 représente un bon moyen de faire connaître les recommandations.

« Je ne savais pas qu'il y avait des reco HAS sur le dépistage. C'est grâce à l'étude que je m'en suis rendu compte. » - MG2

« Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a toujours 30 à 40% des femmes qu'on voit qui pourraient être victimes » - MG6

« 'il faut peut-être que je le fasse de manière plus systématique et réinterroger mes patientes. J'ai réinterrogé une patiente et j'ai eu une réponse positive de façon assez inattendue. Ça m'a fait un rappel que je dois encore être vigilant. » - MG2

« Ça m'a conforté dans le fait de dépister et après j'ai fait des recherches sur les associations près de chez moi, pour les victimes de violences » - MG1

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LA RECOMMANDATION SIMPLIFIÉE

Ajouter des informations sur le fait que la révélation et le fait de chercher de l'aide peut prendre du temps chez certaines femmes pour éviter que les médecins se sentent dans une situation d'échec.

« Ça pourrait être intéressant de donner l'info que c'est une prise en charge longue [...] si je sais que ça prend du temps, je suis moins dans l'attente d'un résultat direct. » - MG1

Outil d'aide au repérage des violences conjugales

Médecins généralistes, vous jouez un rôle-clé dans le repérage des violences. Pensez à **dépister toutes vos patientes** pour savoir si elles ont vécu ou vivent des violences conjugales, même en l'absence de signe d'alerte.

[Cliquez ici pour télécharger la recommandation](#)

Pourquoi dépister ?

- Vos patientes sont concernées : sur 10 patientes vues, 3 à 4 femmes pourraient être victimes de violences conjugales¹.
- En tant que médecin généraliste vous êtes les interlocuteurs privilégiés des femmes et les premiers acteurs à qui elles s'adressent, devant la police et les associations².
- Le dépistage systématique, ça marche : vous avez 3 fois plus de chances de dépister des violences en posant directement la question³.
- Les violences constituent un risque pour la santé des femmes qui doit être évalué de manière systématique, indépendamment du milieu social.

Quand et comment dépister ?

Questionnez toutes vos patientes lors de l'anamnèse comme vous le faites pour les antécédents médicaux ou la consommation de tabac. N'hésitez pas à reposer la question ultérieurement en cas de grossesse ou de séparation.

Aborder le sujet peut vous paraître difficile. Vous pouvez : **Poser la question en vous aidant des exemples suivants** ou en les reformulant avec vos propres mots :

- Comment ça se passe à la maison / avec votre partenaire ?
- Pensez-vous avoir subi des violences (physiques, verbales, psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ?

Et / ou utiliser le questionnaire de prévention fourni, en :

- le mettant en libre-service dans votre salle d'attente ;
- demandant à votre secrétaire de le distribuer ;
- l'utilisant comme guide lors de la consultation.

8 femmes sur 10 pensent qu'il est normal d'aborder ces questions avec son médecin⁴. Pour normaliser le sujet, vous pouvez préciser que vous abordez cette question avec toutes vos patientes.

Que faire en cas de violences ?

- Écouter votre patiente de manière bienveillante, lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que les faits de violences sont punis par la loi et qu'elle peut porter plainte.
- Proposer un 2ème rendez-vous pour en reparler et compléter le dossier médical avec vos observations.
- Rediriger votre patiente vers des spécialistes de votre réseau qui pourront l'accompagner. Voir section « Proposer un accompagnement », ci-contre.

Proposer un accompagnement :

Médical / psychologique

- Unité médico-judiciaire
- Psychologue, psychiatre
- Pédiatre (si enfants présents)

Social

- 115 : Hébergement d'urgence
- 3919 : Violences Femmes Info
- Associations (liste sur arretonslesviolences.gouv.fr)

Judiciaire / juridique

- 17 : Gendarmerie, police
- Accès au droit et informations juridiques : fncidf.info

3 9 1 9 Si vous avez besoin d'aide, consultez declicviolence.fr, le **vade-mecum sur le secret médical**, ou appelez le 3919, une ligne est dédiée aux professionnels de santé.

1. Décliviolences.fr & Haute Autorité de Santé (2023) Repérage des femmes victimes de violence au sein du couple. Argumentaire scientifique. Santé Océans Air France. 2. O'Connell, L., Hegarty, K., Ramsay, J., Davidson, L., Feder, G., & Tait, A. (2022). Screening women for intimate partner violence in health care settings. Cochrane database of systematic reviews. 3. Palusz, M. (2012). Repérage par le médecin généraliste des violences sexuelles faites aux femmes : le point de vue des patientes. Médecine humaine et pathologie.

Ajouter des suggestions de questions à privilégier pour optimiser l'efficacité du dépistage (par exemple les questions adaptées de WAST dans le questionnaire de prévention)

Souligner la disponibilité des ressources locales sur des sites comme arretonslesviolences.gouv.fr et [declic-violences](https://declic-violences.fr) et ajouter un espace pour que les médecins puissent ajouter eux-mêmes des ressources locales.

« Je ne sais pas si tout le monde a des spécialistes de réseau. C'est important d'ajouter les associations locales...[si le médecin dirige la patiente vers des associations locales], on a plus de chances qu'elle y aille » - MG3

LE QUESTIONNAIRE A ÉTÉ LU PAR LA MAJORITÉ DES MÉDECINS MAIS A ÉTÉ TRÈS PEU UTILISÉ ET N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ COMME PRÉVU

Constats

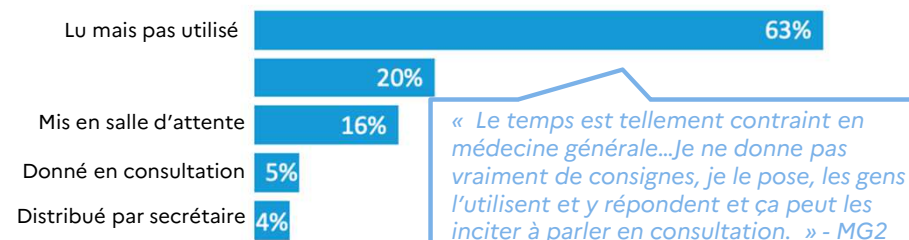
- **3 médecins sur 4 ont lu le questionnaire**, mais parmi ces derniers, près de deux tiers déclarent ne pas l'avoir utilisé (63%), par oubli (45%) ou par manque de temps (21%).
- Le questionnaire a été **principalement utilisé pour guider la conversation**. Les entretiens révèlent que les médecins ont apprécié les questions mentionnées dans le questionnaire et adaptées de la version courte du questionnaire WAST.

Recommandations

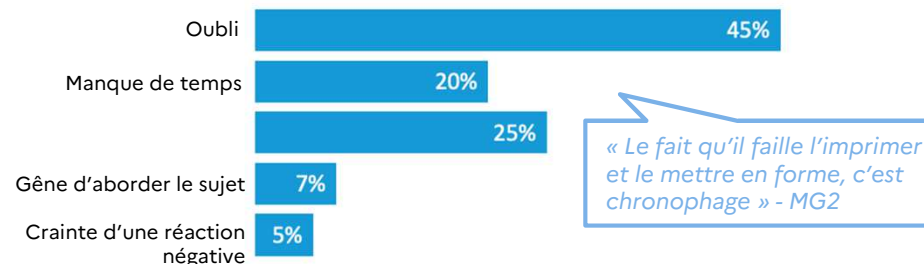
- Ces questions (« En général, comment décririez-vous votre relation avec votre partenaire ? », « Comment arrivez-vous à résoudre les tensions avec votre partenaire ? ») pourraient donc être ajoutées à la recommandation simplifiée.

« Je vais l'imprimer et le mettre juste à côté de mon bureau comme ça je me relis les questions de temps en temps et presque les apprendre par coeur, pour qu'elles reviennent naturellement. » - MG1

Comment avez-vous utilisé le questionnaire de prévention ?*



Pourquoi n'avez-vous pas utilisé le questionnaire ?*



*La somme de ces valeurs dépasse 100, car les MG pouvaient sélectionner plusieurs options.

Les MG ayant choisi d'utiliser le questionnaire de prévention sont plus à même d'être des femmes. D'autres caractéristiques sociodémographiques et professionnelles telles que l'âge, le nombre d'années d'expérience ou encore le nombre de patientes vues n'affectent pas la probabilité d'utiliser le questionnaire.

LE QUESTIONNAIRE N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ COMME PRÉVU QUAND IL A ÉTÉ DISTRIBUÉ OU MIS À DISPOSITION DES PATIENTES

Constats

- Un médecin sur cinq qui avait lu le questionnaire l'a mis en salle d'attente ou a demandé à son ou a secrétaire de le distribuer.
- Les médecins qui ont mis ces questionnaires à disposition des patientes constatent que la **majorité des questionnaires a été emportée**. Mais les patientes n'ont pas rendu ces questionnaires remplis lors de la consultation et il n'est donc pas possible de savoir comment elles l'ont utilisé.

Recommandations

- Le questionnaire avait été pensé pour simplifier la tâche des médecins tout en ayant en tête qu'il pouvait représenter un **risque d'effet rebond** si les médecins avaient l'impression d'avoir accompli l'acte de dépistage par le seul partage du questionnaire.

Gagnez du temps avec ce questionnaire de prévention en santé

1 • Remplissez le questionnaire

2 • Donnez-le à votre médecin pour approfondir ces points lors de la consultation

Numéros d'urgence

- Urgences médicales (SAMU) : 15
- Police, gendarmerie : 17
- Pompiers : 18
- Urgences par SMS : 114
- Hébergement d'urgence : 115

Numéro d'écoute

3 9 19 Violences Femmes Info pour l'écoute et l'orientation des personnes victimes de tous types de violences et de leur entourage.

Anonyme, accessible 24h/24 et 7j/7 et gratuit depuis un poste fixe ou mobile en métropole et dans les DOM. Consultez aussi : arretonslesviolences.gouv.fr

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Première page du questionnaire de prévention comportant les instructions et numéros d'urgence

LE QUESTIONNAIRE SUSCITE DES RÉACTIONS VARIÉES PARMI LES MÉDECINS

Constats

- Parmi les médecins généralistes qui ont lu le questionnaire, deux tiers l'ont trouvé utile (55% plutôt utile, 11% très utile).
- Les entretiens ont néanmoins montré que les avis divergent quant à son contenu. Certains médecins louent la **normalisation du sujet** qui permet de faire « un premier pas progressif dans la prise de conscience » grâce à des **questions discrètes et peu intrusives à utiliser ou se réapproprier**. D'autres préfèrent traiter le sujet des violences différemment des autres sujets de prévention et ne souhaitent pas l'aborder au même titre que le tabagisme ou la consommation d'alcool.

Recommandations

- Cette diversité d'opinion suggère que le questionnaire pourrait ne pas faire l'unanimité en cas de mise à l'échelle. De plus, les médecins se sont plaints du temps requis pour l'imprimer, le plier et le mettre à disposition et préféreraient des outils prêts à l'emploi. Une solution plus souple et demandant moins d'efforts de mise en place semblerait plus adaptée.

« Mettre la question sur les violences parmi d'autres questions de santé générale permet de montrer aux patients qu'ils peuvent nous en parler comme tout autre sujet de consultation » - MG6

« Quand même ça ne parle pas cash des violences, ça parle de la relation familiale...C'est quand même assez ouvert » - MG1

« les violences c'est subir, pas agir, alors que si je fume des cigarettes, c'est moi qui fais » - MG3

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LE QUESTIONNAIRE DE PRÉVENTION

Le questionnaire visait à :

- diminuer la gêne ressentie par les médecins et les femmes car certaines études montrent que les patientes préfèrent remplir le questionnaire elles-mêmes plutôt que de se voir poser la question (O'Doherty et al., 2015; Phelan, 2007).
- faire gagner du temps aux médecins car ils auraient pu ne traiter la question des violences conjugales qu'en cas de besoin (si les scores sont élevés).

Cependant, ces deux freins ne sont pas levés si les patientes ne rendent pas le questionnaire et si le médecin ne le réclame pas. Il existe même un risque potentiel d'effet rebond si les médecins ont l'impression d'avoir accompli l'acte de dépistage par le seul partage du questionnaire.

Nous recommandons donc :

- **d'intégrer les questions adaptées du questionnaire WAST** qui ont été appréciées des médecins **dans la recommandation simplifiée**
- **de proposer un support indépendant contenant des ressources utiles** (marque-page, dépliant, poster, etc.) pour renforcer la confiance des médecins dans leur capacité à fournir un soutien et pour normaliser le sujet des violences conjugales au cabinet (le support pourrait se trouver sur le bureau du médecin et en salle d'attente). Cela permettrait aux patientes d'obtenir un soutien même si le médecin ne leur pose pas de question.



Exemple de marque-page contenant un QR code pour avoir des contacts locaux



Exemple de poster contenant un QR code avec les ressources d'associations locales

CONCLUSION

PRINCIPALES OBSERVATIONS

1

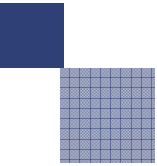
- Les médecins ayant reçu les solutions dépistent 2 femmes de plus par semaine (soit, une augmentation de 76% du nombre de dépistages réalisés).
- Néanmoins, les femmes dépistées ne représentent qu'une minorité des patientes (7,9% des femmes chez les médecins ayant reçu les solutions, contre 4,5% dans le groupe Contrôle).

2

- Les violences restent un sujet difficile à aborder et les solutions n'ont pas amélioré l'aisance des médecins qui préfèrent repérer de manière ciblée plutôt que systématique.
- Des efforts de normalisation du sujet auprès des MG et des patientes restent donc nécessaires pour prétendre à une systématisation du dépistage.

3

- La recommandation simplifiée a beaucoup plu, notamment les conseils et les accompagnements à proposer, qui permettent de former et d'outiller des médecins souvent réticents de dépister sans savoir que faire ensuite.
- Le questionnaire de prévention n'a été utilisé que par une minorité de médecins et ne fait pas l'unanimité.
- Les avis divergents autour du questionnaire montrent la diversité des pratiques de dépistage des violences et suggèrent qu'un travail supplémentaire permettrait de trouver une solution plus adaptée.



Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

- O'Doherty, L., Hegarty, K., Ramsay, J., Davidson, L. L., Feder, G., & Taft, A. (2015). Screening women for intimate partner violence in healthcare settings. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007007.pub3>
- Phelan, M. B. (2007). Screening for Intimate Partner Violence in Medical Settings. *Trauma, Violence, & Abuse*, 8(2), 199–213. <https://doi.org/10.1177/1524838007301221>
- Schwartz, S. H. (1977). Normative Influences on Altruism¹¹This work was supported by NSF Grant SOC 72-05417. I am indebted to L. Berkowitz, R. Dienstbier, H. Schuman, R. Simmons, and R. Tessler for their thoughtful comments on an early draft of this chapter. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in Experimental Social Psychology* (Vol. 10, pp. 221–279). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60358-5](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60358-5)
- Société scientifique de médecine générale, & Agence pour une meilleure qualité de vie. (2018). Détection des violences conjugales. Guide de pratique clinique. SSMG.
- Venis, S., & Horton, R. (2002). Violence against women: A global burden. *The Lancet*, 359(9313), 1172–1172. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08251-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08251-X)
- World Health Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council., & WHO. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf

BIBLIOGRAPHIE

- Boismain, A., & Gaudin, M. (2012). Identification des freins des médecins généralistes à pratiquer le dépistage des violences conjugales auprès de leurs patientes: Étude qualitative par entretiens semi dirigés avec des médecins libéraux et salariés en Isère. 325.
- Chamberlain, L., & Perham-Hester, K. A. (2002). The Impact of Perceived Barriers on Primary Care Physicians' Screening Practices for Female Partner Abuse. *Women & Health*, 35(2–3), 55–69. https://doi.org/10.1300/J013v35n02_04
- Guiguet-Auclair, C., Boyer, B., Djabour, K., Ninert, M., Verneret-Bord, E., Vendittelli, F., & Debost-Legrand, A. (2021). Validation de la version française d'un outil de dépistage des violences conjugales faites aux femmes, le WAST (Woman Abuse screening Tool). *Bulletin d'épidémiologie hebdomadaire*, (2), 32-40.
- imago. (2019). Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple: Impact et perception de la recommandation HAS en médecine générale. Enquête auprès des médecins généralistes libéraux.
- Ifop. (2020). Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple.
- Ipsos Public Affairs. (2020). Résultats d'enquête. Enquête d'évaluation des recommandations de la HAS auprès des médecins généralistes.
- Jaspard, M., & Saurel-Cubizolles, M. (2003). Violences envers les femmes et effets sur la santé. Présentation de l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff). Jaspard M, ed. Les violences envers les femmes en France. Une enquête nationale. Paris, 229–266.
- McCord-Duncan, E. C., Floyd, M., Kemp, E. C., Bailey, B., & Lang, F. (2006). Detecting potential intimate partner violence: which approach do women want?. *FAMILY MEDICINE-KANSAS CITY-*, 38(6), 416.
- Michie, S., Van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implementation science*, 6(1), 1-12.
- Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Résultats de l'enquête nationale auprès des sages-femmes en activité sur les violences faites aux femmes. Paris: MIPROF; 2015.
<http://unssf.org/wp/wp-content/uploads/2018/08/Enqu%C3%AAt-e-nationale-aupr%C3%A8s-des-sages-femmes-en-activit%C3%A9-MIPROF-2015.pdf>
- Nectoux, M., Baffert, S., & Munier, C. (2010). Coût des violences conjugales envers les femmes: Les apports de l'enquête EVS à un chiffre global pour la France, Violences et santé en France: État des lieux, (Collection Etudes et Statistiques, pp. 221–234).



**MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES**

*Créer
Agir
Participer*



Ce rapport a été réalisé par les équipes de la
Direction interministérielle de la transformation publique
et le Behavioral Insights Team
pour le compte de la Haute Autorité de santé (HAS)

www.modernisation.gouv.fr

Novembre 2022